UROLOGIA · AULA 1 · INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

Infecções sexualmente transmissíveis

Úlcera, corrimento uretral e verruga genital: como reconhecer a síndrome e tratar o paciente já na primeira consulta, sem esperar exame.

F

Dr. Fábio Luiz de Souza

Urologista · Professor de Urologia do curso de Medicina da Faculdade Assis Gurgacz

- Graduado em Medicina pela Universidade São Francisco
- Cirurgião geral pelo Hospital Santa Marcelina de São Paulo
- Urologista formado pelo Hospital Santa Marcelina de São Paulo
- Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia

TRÊS NÚMEROS PARA LEVAR

340 milhões
de casos estimados no mundo: todo médico vai atender

2,4 milhões
de unidades de penicilina benzatina tratam a sífilis primária e a secundária

2 remédios
em dose única tratam a uretrite: azitromicina e ciprofloxacino

NESTA APOSTILA

00	Recados da disciplina	2
01	Por que essas infecções importam	2
02	A abordagem sindrômica	5
03	Sífilis	6
04	Cancroide	10
05	Herpes genital	12
06	Uretrites: gonorreia e clamídia	13
07	Papilomavírus humano e condiloma acuminado	15
08	O essencial da aula	17

Organizada a partir da transcrição da aula, com os erros da transcrição automática corrigidos e a linguagem ajustada. A legenda de cores está na página 2.

COMO LER ESTA APOSTILA

- **Azul** conteúdo da aula e raciocínio
- **Vermelho** alerta, erro comum ou armadilha
- **Roxo** complemento que não foi dito em aula
- **Verde** dose ou valor de referência
- **Laranja** fala ou parêntese do professor
- PROVA **Marca de prova** o ponto que cai na prova

00 Recados da disciplina

AVISOS · FOCO DE ESTUDO

Não houve data de prova nem aviso de nota nesta aula, mas o Dr. Fábio deixou claro o que considera essencial e o que pode ficar de lado.

AULAS-CHAVE	Esta aula e as de urgência são, para ele, as mais importantes do curso: é onde o médico que não é urologista mais pode ajudar. O que é de alta complexidade fica com o urologista.
O MÍNIMO	Se não lembrar de mais nada, lembre da **abordagem sindrômica**: o paciente com úlcera ou corrimento sai do consultório tratado.
FICA DE FORA	Linfogranuloma venéreo: pulado em aula por ser pouco frequente no Brasil. Segundo ele, não aparece na prova.
RESIDÊNCIA	Ele avisou que costumam cair em provas de residência: sífilis em geral, reação de Jarisch-Herxheimer, cancro misto de Rollet e os tipos 16 e 18 do papilomavírus. Esses pontos levam a marca PROVA nesta apostila.

> *"Não quer lembrar de nada desta aula? Lembre só da parte sindrômica."*
>
> DR. FÁBIO, SOBRE O QUE LEVAR DA AULA

01 Por que essas infecções importam

EPIDEMIOLOGIA · ABORDAGEM INTEGRAL · VACINAS

As infecções sexualmente transmissíveis são descritas desde sempre. Os micro-organismos transmitidos pelo sexo se aproveitam de uma necessidade humana: nós nos reproduzimos pelo sexo, e eles se espalham do mesmo jeito. A incidência estimada no mundo é de **340 milhões de casos**, e todo médico vai atender esses pacientes: quem dá plantão, o ginecologista, quem trabalha no posto de saúde e até o dermatologista. O professor do Dr. Fábio nessa área, no estágio no Hospital das Clínicas de São Paulo, foi o Dr. Jorge, um dermatologista que só tratava doenças transmitidas pelo sexo.

Uma porta aberta para outras infecções

Algumas dessas doenças, isoladas, têm pouca importância. O herpes genital é como o herpes da boca: muita gente tem, a lesão dura uns 10 dias e vai embora. O problema na região genital é outro: a ferida vira uma **porta**

aberta para micro-organismos que causam doença sistêmica, como o vírus da imunodeficiência humana e os vírus das hepatites B e C.

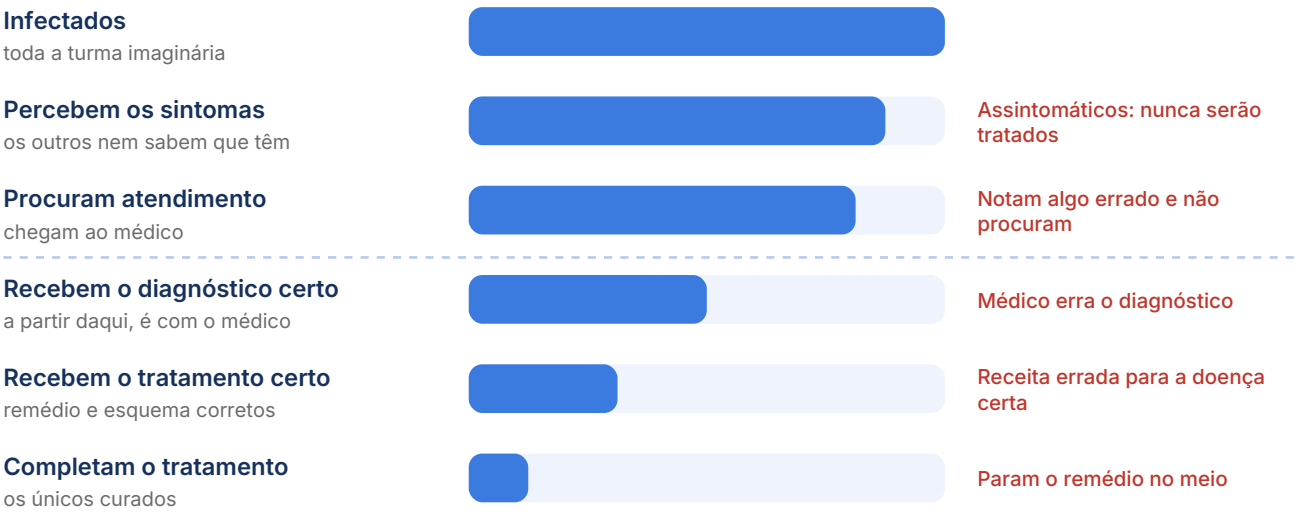
Tratar essas infecções resolve o problema que o paciente tem hoje e deixa o pênis mais saudável, o que dificulta pegar a próxima. E quem já teve uma infecção dessas provavelmente precisa rever alguma coisa na vida sexual. Um estudo antigo, feito durante o alistamento militar, mostrou que **15% dos rapazes de 18 anos** já tinham recebido o diagnóstico de alguma infecção sexualmente transmissível; como o estudo é velho, o número hoje deve ser pior.

A ÚNICA MEDIDA QUE FUNCIONOU

De tudo o que já se tentou para evitar essas infecções, a única medida que comprovadamente mudou a epidemiologia foi o **uso regular de preservativo**. O resto, nas palavras do professor, é quase bruxaria. (E, segundo ele, o primeiro preservativo foi inventado pelo mesmo homem do pneu: dois problemas resolvidos, e os dois dão confusão quando furam.)

Onde os pacientes se perdem

Para mostrar por que tão poucos se curam, o Dr. Fábio usou a turma como população imaginária: todos pegaram a mesma doença inventada na mesma festa. A partir daí, cada etapa deixa gente pelo caminho.



Acima da linha tracejada: campanhas e conscientização.
Abaixo dela, do atendimento em diante: diagnóstico, receita e adesão dependem do médico.

Barras ilustrativas: a aula usou uma turma imaginária, sem porcentagens reais.

Os assintomáticos nunca saberão que estão doentes e nunca serão tratados. Dos que têm sintomas, alguns notam e simplesmente não procuram ajuda. Entre os que chegam ao médico, parte recebe o diagnóstico errado (e trata outra doença), parte recebe o remédio errado para a doença certa e parte abandona o tratamento no meio, por exemplo para ir a uma festa. No fim, só uma pequena parcela termina curada. Do atendimento para cima, o que ajuda são campanhas e conscientização; do atendimento para baixo, a responsabilidade é do médico.

ARMADILHA: PEDIR O EXAME E ESPERAR A VOLTA

O paciente que sai só com o pedido de exame pode ficar com vergonha e não voltar. É uma chance perdida, e talvez não haja outra.

“Ninguém pode perder nenhuma chance de tratar alguém com uma doença dessas, porque talvez não exista a segunda chance.”

DR. FÁBIO, SOBRE A CASCATA DO CUIDADO

Abordagem integral: tudo na primeira consulta

ABORDAGEM INTEGRAL

Diagnosticar, tratar e aconselhar, de preferência tudo no primeiro contato com o paciente.

DIAGNOSTICAR	TRATAR	ACONSELHAR
Reconhecer a síndrome no exame e rastrear as outras infecções.	O paciente sai do consultório com a receita na mão.	Explicar a doença, a prevenção e o que fazer se não melhorar.

- **Espera curta.** Os centros de referência em doenças infecciosas e parasitárias funcionam de porta aberta e deveriam atender no mesmo dia, porque ninguém garante que o paciente volte amanhã.
- **Rastrear as outras.** Se pegou uma, nada impede que tenha pegado outra. Diante de uma gonorreia, por exemplo, rastreie o vírus da imunodeficiência humana e as hepatites B e C, e pergunte sobre contatos anteriores.
- **Tratamento eficiente.** Que cure a maioria dos pacientes e, de preferência, seja gratuito: tem gente que deixa de tratar por não ter dinheiro.

O REMÉDIO IDEAL

É aquele que o paciente toma **pela boca, uma única vez**, de graça, e que resolve o problema. Quando ele não existir, chegue o mais perto possível: o antibiótico mais eficaz pelo menor número de dias, para aumentar a adesão. Evite injeção, porque tem paciente que deixa de se tratar só por causa dela.

“Você não precisa de grandes recursos: só de uma caneta, um cérebro funcional e um carimbo.”

DR. FÁBIO, SOBRE TRATAR SEM EXAMES

Vacinas: hepatite B e papilomavírus

Toda doença que tem vacina deve ser vacinada. Entre as infecções sexualmente transmissíveis, há duas vacinas gratuitas no sistema público: a da hepatite B e a do papilomavírus humano.

VACINA DO PAPILOMAVÍRUS

A dose do posto já protege bem contra o câncer do colo do útero, mas não é o esquema completo. Quem tomou uma dose não recomeça: completa as que faltam por conta própria, a cerca de R$ 800 a R$ 900 por dose.

NO POSTO	FABRICANTE
1 dose	3 doses

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Desde abril de 2024, o sistema público aplica dose única em meninas e meninos de 9 a 14 anos: estudos mostraram proteção semelhante à do esquema antigo contra os tipos 16 e 18. Imunocomprometidos seguem esquema com mais doses, e na bula o esquema completo depende da idade de início.

02 A abordagem sindrômica

ÚLCERA · CORRIMENTO · VERRUGA

Diante de um paciente com infecção sexualmente transmissível, o primeiro passo é encaixá-lo em uma de **três síndromes**. O tratamento sindrômico não se preocupa em descobrir exatamente qual é o agente: trata de uma vez todos os agentes prováveis daquela síndrome. O oposto é o tratamento etiológico, baseado na identificação do micro-organismo, que depende de exames.

ÚLCERA

Lesão ulcerada

Ferida, buraco, covinha. Mais de 90% dos casos são sífilis ou cancroide: trate os dois.

Sai tratado na hora.

CORRIMENTO

Corrimento uretral

Uretrite masculina por transmissão sexual. Quase sempre gonococo ou clamídia: dois remédios em dose única.

Sai tratado na hora.

VERRUGA

Lesão verrucosa

Sem diagnóstico diferencial: é papilomavírus. Doença crônica, de tratamento planejado.

Sai com um plano.

Por que não pedir exames antes? Porque o paciente que sai com um caminhão de pedidos não volta para trazer os resultados: vai à farmácia da esquina e toma o que o balconista der. Na úlcera e no corrimento, ele pode até sair com pedidos para rastrear outras infecções, mas **não pode sair sem tratamento**. A verruga é a exceção: ninguém precisa queimar verrugas na primeira consulta, e o tratamento depende do número, do tamanho e do local das lesões.

● ARMADILHA: VAGINOSE E CANDIDÍASE NÃO SÃO TRANSMITIDAS PELO SEXO

São duas causas muito comuns de corrimento vaginal, que o ginecologista atende quase todo dia. Não há motivo para tratar o parceiro assintomático de quem tem candidíase (nem a parceira de um homem com candidíase), nem para desconfiar dele. A vaginose tem um corrimento feio, com cheiro de peixe podre, e um comentário do tipo "é bom dar uma olhada no marido" pode acabar com um casamento à toa.

Úlcera genital passo a passo

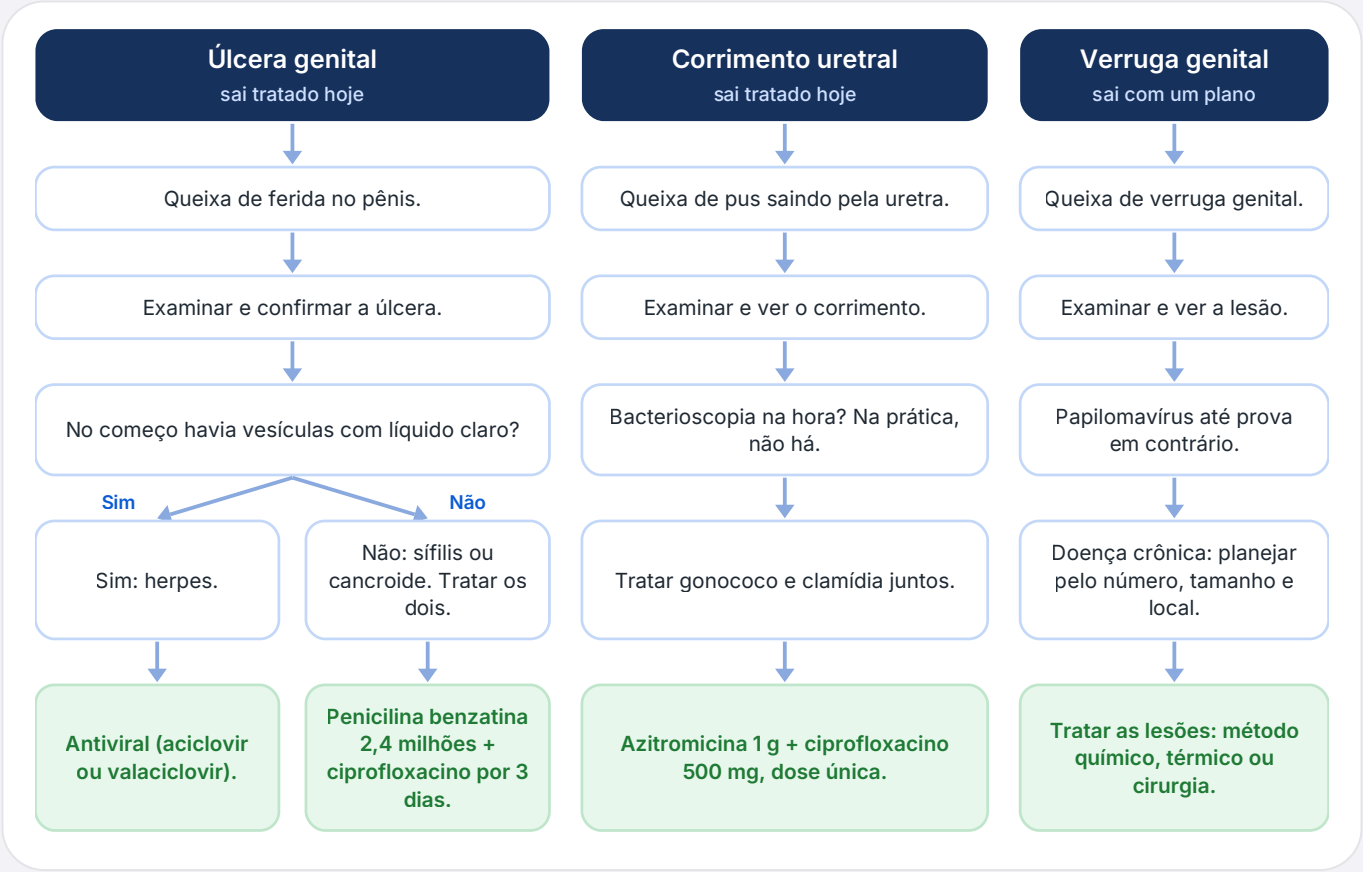
1. **Confirmar a queixa.** O paciente diz que tem uma ferida no pênis; examine e confira se há mesmo uma úlcera.
2. **Perguntar pelas vesículas.** "No começo havia um monte de bolinhas com água dentro?" São vesículas com conteúdo claro, hialino.
3. **Se sim, é herpes.** Nenhuma outra doença começa com vesículas de conteúdo claro que viram úlcera. Trate herpes e pronto.
4. **Se não, é sífilis ou cancroide.** É a resposta mais frequente. Trate os dois: penicilina benzatina e ciprofloxacino pela boca por 3 dias.
5. **Conversar.** Explique o que está fazendo e o que fazer se não melhorar.
6. **Não melhorou?** Encaminhe ao especialista.

"Se você mandar de cara para o especialista tudo o que pode dar errado, nunca vai atender ninguém."

DR. FÁBIO, SOBRE O MEDO DE TRATAR SEM EXAMES

PARÊNTESE DO PROFESSOR

O segredo é conversar, coisa que o médico vem perdendo. Algo como: “Não tenho certeza do que você tem, mas as duas doenças que costumam causar isso são estas. Vou tratar as duas e, se não melhorar, você volta.” É muito diferente de entregar a receita sem explicação, porque aí o paciente desconfia e vai procurar outra solução. Dá trabalho, mas tem de ser feito.



03 Sífilis

TREPONEMA PALLIDUM · FASES · EXAMES · PENICILINA BENZATINA

A sífilis é a doença mais complicada da aula e a de maior interesse científico, por isso aparece tanto em provas de residência. Primeiro conceito: **sífilis não é uma doença genital, é uma doença sistêmica**. Na fase primária ela é do pênis; na secundária, da pele; na terciária, pode atingir qualquer órgão ou tecido.

O agente e a transmissão

O causador é o *Treponema pallidum*. Não é preciso decorar detalhes, mas é preciso saber o que ele é: uma **bactéria**. Uma bactéria diferente, da classe das espiroquetas, mas bactéria, e portanto tratada com antibiótico. Na microscopia de campo escuro, os treponemas aparecem girando em movimentos helicoidais; o Dr. Fábio viu isso no estágio com o Dr. Jorge.

A transmissão é sexual ou vertical (da mãe para o bebê). Por isso o pré-natal pede VDRL (um exame de sangue para sífilis; a sigla vem do laboratório americano que o criou) nos três trimestres, independentemente da vida sexual da gestante. O risco de pegar numa relação com parceiro infectado é de **cerca de 50%**: a sífilis não é altamente contagiosa.

PARÊNTESE DO PROFESSOR: POR QUE A SÍFILIS VOLTOU

A sífilis tinha sumido bastante nos anos 1990, quando o medo da síndrome da imunodeficiência adquirida aumentou o uso de camisinha. Depois que a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana virou uma doença tratável, o preservativo caiu em desuso. Outro fator, na opinião dele, foi a sildenafila (o Viagra): homens mais velhos voltaram a ter vida sexual, sem o hábito da camisinha e com a queixa de que a ereção não se mantém com ela. Já nas casas de prostituição ele não lembra de nenhum caso, porque lá as mulheres exigem o preservativo.

As fases da doença

A sífilis alterna fases de atividade e de remissão.

Contato sexual → **Secundarismo** → **Depois do secundarismo** → tempo

Primária

10 a 90 dias após o contato (média de 3 semanas)

- Cancro duro: úlcera única, borda elevada e endurecida, fundo limpo, sem dor.
- Linfonodos podem aumentar, sem destaque.
- Some sozinho em 2 a 3 semanas: o paciente acha que sarou.

Secundária

6 semanas a 6 meses depois

- Fase da pele: manchas vermelhas no tronco, que lembram alergia.
- Pápulas nas palmas das mãos e nas plantas dos pés.
- Condiloma plano nas dobras.
- Pode se repetir.

Latente

sem sintomas

- Recente: menos de 1 ano de contágio.
- Tardia: mais de 1 ano ou tempo desconhecido.

ou

Terciária

hoje rara

- Qualquer órgão: goma, demência, aneurisma da aorta, artropatia de Charcot.

Exames: VDRL e FTA-Abs sobem já na fase primária. Pelo menos 80% dos pacientes chegam à consulta da lesão com VDRL positivo.
Depois do tratamento, o VDRL cai até zerar (em até 2 anos na maioria); o FTA-Abs fica positivo para sempre.

PRIMÁRIA

Cancro duro

Cerca de 3 semanas após o contato, mas pode variar de 10 a 90 dias: a incubação ajuda pouco no raciocínio. Úlcera única, borda elevada e endurecida (daí "cancro duro"), fundo liso e limpo, sem cheiro. É **indolor**: dá para apertar e mexer. Linfonodos podem aumentar, sem destaque. Some sozinha em 10 a 20 dias, e o paciente acha que sarou.

SECUNDÁRIA

A fase da pele

De 6 semanas a 6 meses depois. Manchas vermelhas no tronco (exantema morbiliforme), que lembram reação alérgica. O mais característico são as **sifílides**: pápulas nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Nas dobras, lesões papulo-hipertróficas que descamam: o condiloma plano. O secundarismo pode se repetir mais de uma vez.

"Se a lesão parece bonita, redondinha, com borda de vulcãozinho e fundo limpo, pense em sífilis."

DR. FÁBIO, SOBRE O CANCRO DURO

ARMADILHA: A SECUNDÁRIA PARECE ALERGIA

Muitas vezes o paciente tomou algum remédio e de repente ficou todo manchado. Lesões nas palmas e plantas ajudam: na criança, pense em doença mão-pé-boca (vírus Coxsackie); no adulto, pense em sífilis secundária. O Dr. Fábio já fez esse diagnóstico no pronto-socorro.

LATENTE

Sem sintomas

Depois do secundarismo, a doença pode ficar latente. É **recente** quando o contágio tem menos de 1 ano e **tardia** quando tem mais de 1 ano ou tempo desconhecido. Exemplo comum: o paciente faz um checkup, o VDRL vem positivo e ele não lembra de ferida nenhuma. Como não se sabe há quanto tempo é, pense no pior: latente tardia, com mais remédio.

TERCIÁRIA

Qualquer órgão ou sistema

Hoje rara: muita gente toma antibiótico por outro motivo e trata a sífilis sem querer. Os livros de semiologia antigos estão cheios de fotos de pacientes mutilados pela goma.

- **Pele e mucosas:** goma sifilítica, úlceras crônicas.
- **Neurológico:** tabes dorsalis, hoje raríssima, e demência. Pacientes com diagnóstico de Alzheimer podem ter VDRL positivo no líquor.
- **Cardiovascular:** aneurisma da aorta, uma massa pulsátil no tórax ou no pescoço.
- **Articular:** artropatia de Charcot, difícil de separar da artrose.

Exames: cada um tem sua função

O diagnóstico é clínico, e o raciocínio é sindrômico. Pelo aspecto da lesão dá para suspeitar, mas, mesmo com 23 anos de prática, o Dr. Fábio nunca abandonou o tratamento sindrômico: a diferença de remédio é pequena demais. Os exames de sangue são de dois tipos, com intenções bem diferentes. O FTA-Abs é um teste de anticorpos treponêmicos fluorescentes com absorção.

	VDRL	FTA-Abs
TIPO	Não treponêmico	Treponêmico
RESULTADO POSITIVO	Sífilis ou outras doenças, como as reumatológicas (artrite reumatoide)	Sífilis: é específico
LEITURA	Quantitativo, em títulos	Positivo ou negativo
DEPOIS DE TRATAR	Os títulos caem até zerar, em até 2 anos na maioria	Fica positivo para sempre: é uma cicatriz sorológica
SERVE PARA	Acompanhar: um antes do tratamento (o ponto zero) e os seguintes	Confirmar o diagnóstico, uma vez na vida

Os dois sobem já na fase primária: pelo menos **80% dos pacientes** chegam com a lesão e o VDRL positivo. Vale pedir VDRL e FTA-Abs na primeira consulta, mas o paciente não pode sair só com o pedido: tem de sair tratado. Se ele vai fazer os exames ou não, é problema dele; tomando o remédio, ficará bem.

MICROSCOPIA DE CAMPO ESCURO

É a única forma de ver o treponema "cara a cara", e só funciona em duas situações: secreção do fundo do cancro duro ou raspado do condiloma plano. Não é um recurso rápido nem disponível em qualquer lugar, e o Dr. Fábio nunca pediu, porque atrasaria o tratamento. Na prática, esqueça.

Tratamento: penicilina benzatina

O tratamento é feito com penicilina, o primeiro antibiótico, descoberto por acaso. O treponema é tão sensível que qualquer antibiótico o mata: não é raro aparecer FTA-Abs positivo com VDRL negativo em quem nunca tratou sífilis, porque um antibiótico tomado por outro motivo resolveu sem querer. Mais do que a potência ou o espectro, o que importa é o **tempo de exposição** ao antibiótico.

Por isso a penicilina benzatina (a Benzetacil) é tão boa: ela cristaliza no músculo e vai se dissolvendo aos poucos, mantendo nível de antibiótico por mais de 10 dias. É também por isso que dói tanto e a nádega fica doída por uma semana. Só não use penicilina quando o paciente tiver alergia comprovada a ela.

SÍFILIS PRIMÁRIA OU SECUNDÁRIA

Cada ampola tem 1,2 milhão de unidades, e não se aplicam duas no mesmo glúteo: duas ampolas, uma em cada lado.

2,4 milhões
UNIDADES, DOSE ÚNICA

TERCIÁRIA, LATENTE TARDIA OU DE TEMPO DESCONHECIDO

Doença mais avançada, mais remédio: o mesmo par de ampolas, repetido uma e duas semanas depois.

3 × 2,4 milhões
UMA VEZ POR SEMANA

COMO ESCREVER A RECEITA

Penicilina benzatina 1.200.000 unidades, 2 ampolas. Aplicar 1 ampola por via intramuscular em cada glúteo, em dose única. Deixe isso explícito: são duas aplicações, mas uma dose só. A enfermagem tem obrigação de saber, mas erros acontecem quando ninguém confere.

COMPLEMENTO: LATENTE RECENTE

O protocolo do Ministério da Saúde trata a sífilis latente recente (menos de 1 ano) como a primária e a secundária.

2,4 milhões
UNIDADES, DOSE ÚNICA

Se o paciente for alérgico, use **doxiciclina ou ceftriaxona** (cefalosporina de terceira geração). O problema é o tempo longo de tratamento: quanto mais remédio e por mais tempo, menor a chance de o paciente tomar. Na **neurossífilis** (VDRL positivo no líquor), a benzatina não serve, porque não atravessa a barreira hematoencefálica: usa-se penicilina cristalina na veia, a única penicilina que atravessa. Esse caso não fica com o urologista.

Reação de Jarisch-Herxheimer PROVA

ARMADILHA: NÃO É ALERGIA

O paciente com sífilis toma a benzatina e, cerca de 2 dias depois, volta vermelho e se coçando, com um quadro parecido com urticária. O erro é concluir que ele é alérgico à penicilina e proibi-la para sempre. Na sífilis, essa reação é **esperada**: é a resposta imunológica à morte maciça de treponemas. Tranquilize o paciente, receite um remédio para a coceira e siga.

Sobre a ideia de que a benzatina não pode ser aplicada na farmácia: o risco de reação anafilática grave é de cerca de 0,002%, ou 2 em cada 100 mil aplicações. Para o Dr. Fábio, obrigar todo mundo a procurar um hospital por um risco desse tamanho não faz sentido.

Controle de cura

O controle é feito com **VDRL**; o FTA-Abs não adianta, porque fica positivo para sempre. Os títulos devem cair, e em até 2 anos a maioria dos pacientes está com VDRL zerado. Se o VDRL estava caindo ou zerado e volta a subir, normalmente é uma nova infecção, dados os hábitos de alguns pacientes: o professor tem paciente que já "completou o álbum", com úlcera, uretrite e papilomavírus.

> *"Estudar sífilis a fundo é infernal. Mas se você souber isto aqui, já está melhor que a maioria."*
> DR. FÁBIO, SOBRE A SÍFILIS

04 Cancroide

HAEMOPHILUS DUCREYI · CANCRO MOLE · CIPROFLOXACINO

O cancroide, conhecido como **cancro mole**, é a segunda causa de úlcera genital e, junto com a sífilis, forma o tratamento sindrômico da úlcera. O agente é o *Haemophilus ducreyi*, um cocobacilo Gram-negativo que não causa nenhuma outra doença conhecida. Como é bactéria, trata-se com antibiótico; outra classe de remédio não adianta. A incubação é curta, de 3 a 5 dias, e o contágio é muito maior que o da sífilis: cerca de 80% de transmissão em uma única relação.

	Sífilis primária	Cancroide
NOME POPULAR	Cancro duro	Cancro mole
AGENTE	*Treponema pallidum*, espiroqueta	*Haemophilus ducreyi*, cocobacilo Gram-negativo
INCUBAÇÃO	Cerca de 3 semanas (10 a 90 dias)	3 a 5 dias
TRANSMISSÃO	Cerca de 50%	Cerca de 80% em uma relação
LESÕES	Única	Múltiplas
DOR	Indolor	Dolorosa
ASPECTO	Borda elevada e endurecida, fundo limpo	Borda irregular, fundo sujo, secreção necrótica e com mau cheiro
LINFONODOS	Podem aumentar, sem destaque	Em cerca de 50%, de um lado só, podendo fistulizar

A lesão da sífilis é uma pereba "elegante"; a do cancroide é feia de ver. Sem tratamento precoce, os linfonodos da virilha podem se romper para fora e ficar drenando pus e linfa, um dos motivos para tratar cedo.

Cancro misto de Rollet PROVA

ARMADILHA: AS DUAS NA MESMA LESÃO

Sífilis e cancroide podem estar juntos na mesma úlcera: é o cancro misto de Rollet. Quem trata só o que "tem certeza" que é pode deixar uma das duas doenças sem tratamento. Mais uma razão para não abandonar o tratamento sindrômico, a não ser que você vá se tornar especialista na área.

Exames que pouco ajudam

O diagnóstico é basicamente clínico. O laboratório pode corar pelo Gram o material do fundo da lesão (coloração, não cultura): aparecem cocobacilos Gram-negativos dentro das células, o que sugere o agente, mas não dá o nome dele. A reação em cadeia da polimerase (PCR) para o *Haemophilus ducreyi* é o padrão-ouro, porém cara, pouco feita e capaz de vir positiva por contato antigo.

> *"Pedir um exame de milhares de reais para uma doença que se trata com seis comprimidos que não custam dez reais? O que o sistema gasta sai do bolso de todos nós."*
>
> DR. FÁBIO, SOBRE O CUSTO DO DIAGNÓSTICO

Tratamento

CANCROIDE: ESCOLHA DA AULA

Seis comprimidos, por menos de R$ 10.

Ciprofloxacino 500 mg
A CADA 12 HORAS, POR 3 DIAS

DOXICICLINA	100 mg a cada 12 horas, por 14 dias. Para alergia ou falta de resposta ao ciprofloxacino.
ERITROMICINA	500 mg a cada 6 horas (4 vezes ao dia), por 14 dias.
CEFTRIAXONA	Alternativa injetável.
HIGIENE LOCAL	As lesões encostam umas nas outras e a doença se espalha por autoinoculação: manter a região sempre limpa.

PARÊNTESE DO PROFESSOR

A doxiciclina é a salvação da lavoura das infecções sexualmente transmissíveis: quando não se sabe mais o que fazer, 14 dias de doxiciclina limpam até a alma. O problema é convencer o paciente a tomar até o fim. Todo antibiótico longo aumenta a chance de abandono.

REGRA DE BOLSO DA ÚLCERA SEM VESÍCULAS

Um par de benzatina e três dias de ciprofloxacino: úlcera genital tratada.

SÍFILIS
Penicilina benzatina 2,4 milhões de unidades, uma ampola em cada glúteo.

CANCROIDE
Ciprofloxacino 500 mg a cada 12 horas, por 3 dias.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

No protocolo brasileiro de infecções sexualmente transmissíveis (Ministério da Saúde, 2020, mantido em 2022), a primeira escolha para o cancroide é azitromicina 1 g pela boca em dose única; o ciprofloxacino por 3 dias e a ceftriaxona 250 mg intramuscular em dose única ficam como alternativas. No tratamento sindrômico da úlcera sem vesículas, o protocolo associa penicilina benzatina 2,4 milhões de unidades e azitromicina 1 g, e reforça que não se deve esperar resultado de exame para tratar.

05 Herpes genital

HERPES SIMPLES · PRÓDROMO · ANTIVIRAIS

O herpes genital entra na aula mais como curiosidade: a evolução é benigna. A lesão aparece, dura alguns dias e vai embora. Em saúde pública, a importância é ser **porta de entrada** para o vírus da imunodeficiência humana, as hepatites e outras infecções.

O que dizer na primeira consulta

O herpes é **incurável**. Diga isso no primeiro dia: muitos pacientes acham que sararam porque a lesão sumiu. Pode ser que ela nunca mais apareça, mas o vírus continua lá. E não confunda com o herpes-zóster:

	Herpes genital ou oral	Herpes-zóster
VÍRUS	Herpes simples	Varicela-zóster, o mesmo da catapora
QUADRO	Vesículas na boca ou nos genitais	Vesículas ao longo do trajeto de um nervo, muito dolorosas, em geral no idoso
GRAVIDADE	Benigno no imunocompetente	Outra doença, sem relação com o herpes genital

Para entrar, o vírus precisa de uma solução de continuidade na pele ou na mucosa. Na relação sexual há vários microtraumas, e é por eles que a infecção acontece.

PARÊNTESE DO PROFESSOR

O Dr. Fábio tem herpes na boca e já beijou a esposa várias vezes durante uma crise sem passar o vírus para ela, porque a boca dela estava íntegra. Pelo mesmo motivo, encostar o dedo íntegro na lesão não faz nascer herpes no dedo.

Pródromo: o aviso antes da lesão

O diagnóstico é clínico; o professor se recusa a pedir exame para herpes. Muitos pacientes têm **pródromo**, sintomas que avisam que a crise vem, como a aura da enxaqueca. Como o vírus é neurotrópico e mora no nervo, o pródromo é neurológico: formigamento e parestesia no local.

Saber se o paciente tem pródromo é útil: ele pode guardar o antiviral na nécessaire e tomar assim que começar o formigamento. Muitas vezes a lesão nem aparece, ou aparece mais leve. É o que o professor faz há anos com o herpes da boca. Sem tratamento, as vesículas rompem em horas e viram ferida, e depois disso pode ser difícil reconhecer o herpes: daí a pergunta sobre as bolinhas d'água no início, que o paciente costuma saber responder. A úlcera some em 7 a 10 dias, até a próxima crise.

Transmissão

Segundo a aula, a transmissão acontece na fase de lesão, com vesículas íntegras ou rompidas. Ter herpes não significa nunca mais poder ter relação com o parceiro: basta evitar a relação desprotegida durante a crise, quando “o parquinho fica fechado”.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

O vírus também pode ser eliminado sem nenhuma lesão (excreção viral assintomática), e boa parte das transmissões acontece assim; o protocolo do Ministério da Saúde menciona esse risco. O preservativo reduz, mas não elimina, a transmissão fora das crises.

Tratamento

O cuidado com a lesão é local: limpeza e água boricada, um líquido secante que ajuda a lesão a secar mais rápido. O antiviral, tomado no pródromo, pode encurtar, suavizar ou até evitar a crise. Qualquer remédio terminado em “ciclovir” funciona; o que muda é a comodidade.

ANTIVIRAIS

O aciclovir cansa (a dose da madrugada costuma ser pulada); o valaciclovir é mais fácil, por um pouco mais de dinheiro.

ACICLOVIR	VALACICLOVIR
4 em 4 horas	12 em 12 horas

QUANDO TRATAR

Só em duas situações o tratamento é obrigatório. Imunocomprometido inclui infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, quimioterapia e corticoide em dose imunossupressora.

PRIMEIRO EPISÓDIO	IMUNOCOMPROMETIDO	CRISES FREQUENTES	CRISES RARAS
Obrigatório: um ciclo pode fazer a próxima crise demorar mais.	Obrigatório: o herpes pode virar doença grave, como encefalite.	Supressivo: antiviral diário por até 1 ano.	A regra, a cada 2 ou 3 anos: 10 dias e acabou.

06 Uretrites: gonorreia e clamídia

GONOCOCO · CLAMÍDIA · DOSE ÚNICA

O paciente chega dizendo que está saindo pus pelo pênis. Você examina e vê o corrimento: é uma **uretrite**, um corrimento uretral purulento. Aqui se fala principalmente da uretrite masculina; na mulher, os mesmos agentes podem causar corrimento uretral e também vaginal, e o quadro é um pouco diferente.

O algoritmo: na prática, só tem um lado

1. **Há bacterioscopia na hora?** Quem tem um laboratório ao lado, como o Dr. Jorge com a farmacêutica na sala vizinha, pode corar a secreção pelo Gram.
2. **Apareceu gonococo:** trate gonococo e clamídia, porque a clamídia não aparece na coloração de Gram.
3. **Não apareceu gonococo:** trate só a clamídia.
4. **Sem bacterioscopia, que é o comum:** trate os dois. Isso está no manual de infecções sexualmente transmissíveis do Ministério da Saúde.

A lâmina da bacterioscopia custa mais do que o comprimido que ela ajudaria a evitar. Não é que o diagnóstico etiológico seja ruim: é que, sem esse laboratório ao lado, não faz sentido.

URETRITE: OS DOIS JUNTOS, DOSE ÚNICA

Para quem prefere injeção, a ceftriaxona em dose única substitui o ciprofloxacino.

CLAMÍDIA
Azitromicina 1 g

GONOCOCO
Ciprofloxacino 500 mg

PARÊNTESE DO PROFESSOR

O Dr. Fábio guarda os comprimidos na gaveta: entrega um de azitromicina e um de ciprofloxacino, o paciente toma ali mesmo com um copo d'água e vai embora tratado. Não é obrigatório fazer assim, mas o paciente comprar dois comprimidos e tomar não mata ninguém. E no dia seguinte ele já está liberado.

ARMADILHA: A COR DO PUS NÃO DIZ O AGENTE

Dizer que a secreção da clamídia é mais branquinha e a da gonorreia mais amarelada é "muita bruxaria". Pelo aspecto não dá para separar: trate os dois. Para fazer tratamento etiológico, é preciso no mínimo uma bacterioscopia.

Gonorreia e uretrite não gonocócica

	Gonorreia	Não gonocócica
AGENTE	*Neisseria gonorrhoeae*, o gonococo	Quase sempre *Chlamydia trachomatis*; raramente ureaplasma, micoplasma ou tricomonas
INCUBAÇÃO	2 a 5 dias	Mais longa
TRANSMISSÃO	Cerca de 50% por relação	Cerca de 20%
QUADRO	Disúria e secreção uretral purulenta; sintomas sistêmicos são raros	Não se distingue clinicamente
EXAMES	Gram; cultura em meio com sangue (Thayer-Martin)	Cultura; sorologia pouco útil; teste rápido caro

O Dr. Fábio nunca pediu cultura de gonococo: na visão dele, a resistência a antibiótico não é um problema que justifique o exame. A uretrite não gonocócica poderia se chamar uretrite clamidiana, de tão frequente que é a clamídia. *Ureaplasma urealyticum* e micoplasma respondem aos mesmos antibióticos que ela, então não há motivo para ir atrás deles. Já a tricomoníase (o *Trichomonas vaginalis* é um protozoário, não uma bactéria) costuma levantar suspeita clínica: corrimento esverdeado, abundante, bolhoso e com mau cheiro.

A clamídia causa muitas doenças: infecção ocular (no recém-nascido e o tracoma), doença inflamatória pélvica, corrimento vaginal e uretrite em homens e mulheres. Por isso a sorologia vem positiva em muita gente que só teve contato com ela em algum momento da vida, até no parto, sem que isso tenha importância clínica.

COMPLEMENTO: PROTOCOLO ATUAL

Esquema do Ministério da Saúde para a uretrite, ambos em dose única.

GONOCOCO
Ceftriaxona 500 mg

CLAMÍDIA
Azitromicina 1 g

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Por causa da resistência do gonococo, o ciprofloxacino saiu dos esquemas brasileiros de uretrite. O protocolo de 2022 usa ceftriaxona no músculo e azitromicina pela boca e alerta para o aumento da resistência também à azitromicina. Na uretrite persistente com suspeita de tricomoníase, usa-se metronidazol por 7 dias. As parcerias sexuais devem ser avaliadas e tratadas, mesmo sem sintomas.

Não melhorou? O plano B

SE NÃO MELHOROU, PENSE EM QUATRO COISAS

Quem faz tratamento sindrômico precisa ter um plano B para quando as coisas não correm bem.

RESISTÊNCIA
Possível, mas incomum. Ele não iria pelo caminho da cultura.

TRICOMONAS
Suspeite pelo corrimento feio. Às vezes tratar é mais fácil que confirmar.

ADESÃO
O paciente tomou o remédio como e pelo tempo indicados? Se não, corrija.

REINFECÇÃO
Voltou a ter relação com a mesma parceria? Pergunte sobre a vida sexual.

Se nada disso explicar, encaminhe ao especialista.

07 Papilomavírus humano e condiloma acuminado

CONDILOMA ACUMINADO · TIPOS 16 E 18 · TRATAMENTO DAS LESÕES

O papilomavírus humano incomoda muito: além de ser sexualmente transmissível, pode ter consequências graves, principalmente na mulher, pela relação com o câncer do colo do útero. Primeiro, os nomes: **papilomavírus humano é o vírus; condiloma acuminado é a doença**. É como pneumococo e pneumonia.

Tipos de alto risco: 16 e 18 PROVA

Há mais de 100 tipos documentados, poucos com importância clínica. Alguns aumentam o risco de câncer: os **tipos 16 e 18** são os de alto risco oncológico, e o professor avisa que isso cai muito em prova de residência. Exemplo: a ginecologista vê uma lesão suspeita no Papanicolau, faz a captura híbrida e encontra um tipo de alto risco. Isso não significa câncer: significa vigilância mais cuidadosa, preventivos em dia e orientação.

O que contar ao paciente

Quase todo mundo tem
O preservativo ajuda pouco: reduz a troca de fluidos, mas não a área de contato. Por isso pega até quem nunca transou sem camisinha. Com a vacinação, isso deve diminuir.

A maioria não tem sintomas
Homens e mulheres passam o vírus adiante sem saber. A transmissão costuma ser sexual, mas há casos documentados por objetos inanimados.

Incubação indefinida
Dá para pegar aos 15 anos e ter a primeira lesão aos 50, casado e com três filhos. É impossível saber quando foi.

Incurável
Trata-se a verruga, que pode voltar; se voltar, retira-se de novo. Diga isso no primeiro dia.

ARMADILHA: A BRIGA DO CASAL

Diante de uma lesão nova em alguém casado, a tentação é concluir que houve traição. Pode ter havido, mas sua obrigação é explicar que a incubação é indefinida: a lesão apareceu agora, e não há como saber quando o vírus foi adquirido.

Diagnóstico

O diagnóstico é clínico e não exige recursos: **verruga genital é papilomavírus até prova em contrário**. A apresentação é variada: pequena, grande, uma ou muitas. Não há nada de errado em cauterizar verrugas sem certeza absoluta do que são; no sistema público seria impossível biopsiar todas. Faça biópsia quando houver dúvida de tumor ou quando o tratamento não estiver funcionando.

No homem, as lesões podem estar em qualquer lugar: glande, meato da uretra (podendo crescer para dentro dela), freio, sulco balanoprepucial (bem típico), púbis e virilha, áreas que a camisinha não cobre. Lesões perianais não significam necessariamente relação anal: o vírus tem tropismo pela região, e homens e mulheres podem se autoinocular durante a higiene.

Na mulher, o rastreio é o preventivo, o Papanicolau: um exame citológico em que as células do colo do útero vão ao patologista, que procura atipias (sinal de câncer) e coilocitose (coilócitos, típicos do papilomavírus). As mulheres fazem preventivo regular por causa desse vírus, porque quase todos os cânceres do colo do útero têm relação com ele. No homem, a relação com o câncer de pênis é bem menor.

CAPTURA HÍBRIDA	Teste molecular que confirma o vírus e diz o tipo, de alto ou baixo risco. No homem quase não se faz, porque não muda a conduta: tratam-se as lesões.
LUPA	Colposcopia na mulher e peniscopia no homem: ampliam a imagem para enxergar melhor as lesões.
BIÓPSIA	A descrição mostra coilócitos na amostra e o diagnóstico histológico de condiloma acuminado.

Condiloma gigante: o tumor que não é câncer

Às vezes o condiloma cresce como uma massa enorme e vegetante, que parece um tumor maligno. A biópsia mostra condiloma acuminado: é o **tumor de Buschke-Löwenstein**, ou condiloma gigante. Histologicamente é condiloma e se comporta como tal: não invade as camadas profundas. Por fora assusta, mas no exame de imagem não ocupa a pelve. Retirado aos pedaços, sai tudo.

DOIS CASOS DA RESIDÊNCIA

No primeiro, um cirurgião oncológico do pronto-socorro fez a amputação parcial do pênis de um paciente com lesão vegetante; o anatomopatológico veio condiloma gigante, e a amputação foi desnecessária. No segundo, mais extenso, o Dr. Fábio e o chefe retiraram a lesão aos pedaços: o pênis e o escroto ficaram sem pele, como no tratamento da síndrome de Fournier. A cirurgia plástica fez o enxerto e, meses depois, o paciente voltou ao ambulatório limpo, sem mau cheiro e satisfeito.

"Se tem dúvida, dê um passo para trás, reavalie, faça um exame, converse com alguém que entende mais. Não vá fazer loucura."

DR. FÁBIO, SOBRE O CONDILOMA GIGANTE

Para comparar: o carcinoma in situ ligado ao papilomavírus é superficial; o câncer invasivo de pênis se aprofunda no órgão. A lesão do papilomavírus, por definição, só acomete a pele.

Tratamento das lesões

Não há cura: o tratamento remove as verrugas e **não muda a história natural** da doença. Lesão pequena pede método simples; condiloma gigante pede cirurgia grande.

MÉTODOS QUÍMICOS

Aplicados por profissional

- **Podofilina.** Antimitótico, o antigo remédio de calo: a verruga diminui até sumir. Muito irritante e teratogênica: evitar em mulheres em idade fértil.
- **Ácido tricloroacético 90%.** Barato e simples, ótimo para a saúde pública. Molha-se um palito de dente, escorre-se o excesso na borda do frasco e encosta-se só a ponta na verruga.
- **Imiquimode.** Imunomodulador que chegou como promessa, a cerca de R$ 1.000 por 2 a 3 semanas, e decepcionou na prática.

MÉTODOS TÉRMICOS

Os mais usados

- **Eletrocauterização.** Com anestesia local; deixa marca. Não usar dentro do canal vaginal, pelo risco de fístula com a bexiga ou o reto; na vulva e na genitália externa, pode.
- **Criocauterização.** Com gás carbônico ou nitrogênio, é a melhor: sem anestesia e pouco desconfortável, mas exige equipamento, por isso fica mais com o dermatologista.
- **Laser.** Caro e desproporcional; a vantagem é estética.

ALERTA: NADA DE ÁCIDO PARA LEVAR PARA CASA

Podofilina e ácido tricloroacético são de uso profissional (um enfermeiro bem treinado pode aplicar). Entregar um frasco de ácido a 90% para o paciente passar em casa é pedir um acidente grave, e eles já aconteceram.

A **cirurgia** fica para quando os outros métodos falham ou há dúvida diagnóstica (biópsia antes de mexer de vez). A saúde pública usa mais métodos químicos, sobretudo o ácido tricloroacético; a privada, mais os térmicos: o urologista gosta de cauterizar, o dermatologista, de congelar.

Hoje meninas e meninos são vacinados. O esquema do posto ajuda a evitar o câncer do colo do útero, que é o objetivo da vacina, mas o Dr. Fábio recomenda aos pacientes completar as três doses.

08 O essencial da aula

REVISÃO

Números da aula

CASOS NO MUNDO
340 milhões
incidência estimada

JÁ TIVERAM UMA INFECÇÃO
15%
dos rapazes de 18 anos

VDRL NA CONSULTA DA LESÃO
80% ou mais
já vem positivo

TRANSMISSÃO POR RELAÇÃO
Cerca de 50%
sífilis e gonorreia

TRANSMISSÃO POR RELAÇÃO
Cerca de 80%
cancroide

TRANSMISSÃO POR RELAÇÃO
Cerca de 20%
uretrite não gonocócica

INCUBAÇÃO DA SÍFILIS

3 semanas

em média; de 10 a 90 dias

INCUBAÇÃO DO CANCROIDE

3 a 5 dias

curta e muito contagiosa

INCUBAÇÃO DA GONORREIA

2 a 5 dias

a não gonocócica demora mais

SÍFILIS RECENTE

2,4 milhões

unidades de benzatina, dose única, uma ampola em cada glúteo

SÍFILIS TARDIA

3 semanas

de 2,4 milhões por semana: terciária, latente tardia ou indeterminada

CONTROLE DE CURA

2 anos

para o VDRL zerar na maioria dos pacientes

A aula em uma linha por tema

Por que importam	São muito frequentes, viram porta de entrada para outras infecções, e só o preservativo mudou a epidemiologia.
Cascata	De todos os infectados, poucos chegam à cura: não perca a chance de tratar.
Abordagem integral	Diagnosticar, tratar e aconselhar na primeira consulta, com remédio pela boca e de preferência em dose única.
Abordagem sindrômica	Úlcera e corrimento saem tratados na hora; verruga sai com um plano.

Úlcera	Começou com vesículas: herpes. Sem vesículas: sífilis e cancroide, tratados juntos.
Sífilis	Doença sistêmica; o FTA-Abs confirma e o VDRL acompanha; penicilina benzatina, e a reação de Jarisch-Herxheimer não é alergia.
Cancroide	Lesões múltiplas, dolorosas e sujas; ciprofloxacino por 3 dias; pode vir junto com a sífilis (Rollet).

Herpes genital	Incurável e benigno; antiviral no pródromo; tratar sempre o primeiro episódio e o imunocomprometido.
Uretrites	Gonococo e clamídia não se separam pela cor do pus: azitromicina 1 g e ciprofloxacino 500 mg em dose única.

Papilomavírus	Incurável, com incubação indefinida; tipos 16 e 18 de alto risco; tratam-se as lesões, sem mudar a história natural.
Vacinas	Hepatite B e papilomavírus, gratuitas no sistema público; para o papilomavírus, o fabricante recomenda três doses.

Erros comuns

ERROS COMUNS

- **Mandar o paciente embora só com o pedido de exame.** Na úlcera e no corrimento, ele sai tratado.
- **Rotular a reação de Jarisch-Herxheimer como alergia à penicilina.** É esperada na sífilis; trate a coceira e siga.
- **Usar o FTA-Abs para controle de cura.** Ele fica positivo para sempre; o controle é com VDRL.
- **Aplicar as duas ampolas de benzatina no mesmo glúteo.** Uma em cada lado, e a receita deve dizer isso.
- **Tentar adivinhar gonococo ou clamídia pela cor do pus.** Trate os dois.
- **Tratar o parceiro de quem tem vaginose ou candidíase.** Não são transmitidas pelo sexo.
- **Confundir herpes genital com herpes-zóster.** São vírus e doenças diferentes.
- **Dar ácido tricloroacético ou podofilina para uso em casa.** São de aplicação profissional.
- **Amputar uma lesão vegetante sem biópsia.** Pode ser condiloma gigante, que sai aos pedaços.

Palavras da aula em linguagem simples

Abordagem integral	Diagnosticar, tratar e aconselhar o paciente, de preferência na primeira consulta.
Abordagem sindrômica	Tratar todos os agentes prováveis de uma síndrome (úlcera, corrimento, verruga) sem esperar exame que identifique o agente.
Autoinoculação	Quando o próprio paciente leva a infecção de uma lesão para a pele vizinha ou para outra região.
Bacterioscopia	Exame da secreção ao microscópio, depois de corada pelo Gram, para ver as bactérias.
Captura híbrida	Teste molecular que detecta o papilomavírus e diz se o tipo é de alto ou de baixo risco.
Coilocitose	Presença de coilócitos, células alteradas típicas da infecção pelo papilomavírus.
Condiloma acuminado	A verruga genital, doença causada pelo papilomavírus humano.
Condiloma plano	Lesão da sífilis secundária nas dobras da pele; não tem relação com o papilomavírus.
Espiroqueta	Classe de bactérias em forma de espiral, como o treponema da sífilis.
FTA-Abs	Teste treponêmico (anticorpos treponêmicos fluorescentes com absorção): confirma sífilis e fica positivo para sempre.
Goma sifilítica	Úlcera crônica da sífilis terciária.
Imunocomprometido	Pessoa com a defesa baixa por doença ou tratamento, como infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, quimioterapia ou corticoide em dose alta.

Microscopia de campo escuro	Microscopia que mostra o treponema vivo; só funciona no cancro duro e no condiloma plano.
Neurossífilis	Sífilis no sistema nervoso; tratada com penicilina cristalina na veia.
Papilomavírus humano	Vírus da verruga genital, conhecido pela sigla em inglês HPV; os tipos 16 e 18 têm alto risco de câncer.

PCR	Reação em cadeia da polimerase: exame molecular que procura o material genético do micro-organismo. No cancroide é o padrão-ouro, mas é caro.
Peniscopia	Exame do pênis com lupa para ampliar a imagem; na mulher, o equivalente é a colposcopia.
Pródromo	Sintoma que avisa que a crise vem, como o formigamento antes da lesão de herpes.

Reação de Jarisch-Herxheimer	Vermelhidão e coceira cerca de 2 dias depois da penicilina na sífilis, pela morte dos treponemas; não é alergia.
Sifílides	Pápulas da sífilis secundária, típicas nas palmas das mãos e nas plantas dos pés.
Teratogênico	Que causa malformação no feto.

Tratamento supressivo	Antiviral diário por até 1 ano, para quem tem crises de herpes muito frequentes.
VDRL	Teste não treponêmico da sífilis: pode dar positivo em outras doenças, mas os títulos caem com o tratamento.
Vesícula	Bolinha com líquido claro (hialino) dentro; no início de uma úlcera genital, indica herpes.

ANOTAÇÕES